

Complicaciones infecciosas profundas del cuello

(Absceso retrofaríngeo, absceso periamigdalino, celulitis y angina de Ludwig)

1. Introducción y relevancia clínica

Las **infecciones profundas del cuello** corresponden a procesos **supurativos o celulíticos** que afectan los espacios **fasciocelulares cervicales**, con riesgo de **diseminación rápida, compromiso de vía aérea y mediastinitis**.

Aunque son poco frecuentes, su potencial gravedad obliga a un **diagnóstico y tratamiento precoz**.

Las más relevantes clínicamente son:

- **Absceso periamigdalino (quinsy)**
- **Absceso retrofaríngeo**
- **Angina de Ludwig (celulitis submandibular difusa)**

Estas entidades pueden amenazar la vida por:

- **Obstrucción de la vía aérea superior**
- **Diseminación séptica (mediastinitis, sepsis, trombosis de vena yugular interna)**
- **Shock séptico y falla multiorgánica**

Relevancia para EUNACOM

- Reconocer síntomas de alarma (disfagia, trismus, voz apagada, babeo, estridor).
 - Diagnóstico diferencial con **faringoamigdalitis simple**.
 - Saber cuándo realizar imágenes, drenaje y derivar urgente a ORL o cirugía.
 - Integrar el manejo antibiótico y soporte de vía aérea.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía relevante

El cuello está compuesto por **espacios fasciales** que actúan como vías de propagación infecciosa:

- **Espacio periamigdalino (parafaríngeo superficial)**
- **Espacio retrofaríngeo (entre fascia bucofaríngea y prevertebral)**
- **Espacio submandibular y sublingual (Ludwig)**

Estos espacios comunican con el **mediastino posterior y superior**, permitiendo la diseminación hacia el tórax.

2.2 Etiología

Las infecciones profundas del cuello suelen ser **secundarias** a:

- Faringoamigdalitis bacteriana (principal).
- Infecciones dentarias o periodontales (especialmente en Ludwig).
- Trauma de mucosa faríngea (espinas, procedimientos).
- Cuerpos extraños o infecciones posintubación.

Gérmenes frecuentes:

- **Streptococcus pyogenes (grupo A)**
 - **Staphylococcus aureus** (incluido MRSA)
 - **Anaerobios** (Bacteroides, Fusobacterium)
 - **Polimicrobianas** en infecciones odontógenas.
-

2.3 Fisiopatología

La infección se inicia en la mucosa orofaríngea o dental → invade planos fasciales → acumula pus o produce celulitis difusa.

La inflamación produce:

- Edema progresivo → **estrechamiento de la vía aérea superior**.
 - Dolor y **trismo** (espasmo de músculos pterigoideos).
 - Riesgo de extensión hacia **mediastino o sistema vascular yugular**.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas generales

- Dolor faríngeo o cervical intenso.
 - Fiebre alta, odinofagia y disfagia progresiva.
 - Voz apagada (“voz de papa caliente”).
 - Sialorrea o babeo.
 - Trismus (dificultad para abrir la boca).
 - Estridor o disnea (signo de alarma).
-

3.2 Tipos clínicos principales

A. Absceso periamigdalino

- Secuela de **amigdalitis bacteriana no tratada**.
- Dolor unilateral con **desviación de la úvula hacia el lado contralateral**.
- Trismus, fiebre, voz de “papa caliente”.
- Halitosis y otalgia refleja.

Signos clave:

- Amígdala abombada, úvula desviada.
 - Dolor cervical ipsilateral.
 - Dificultad para tragar y abrir la boca.
-

B. Absceso retrofaríngeo

- Más común en **niños <5 años**, por infección de ganglios linfáticos retrofaríngeos.
- En adultos: secundaria a traumatismos faríngeos o infecciones cervicales.
- Presenta **babeo, disnea, voz apagada y cuello rígido**.

Signos de alarma: estridor inspiratorio, dificultad respiratoria, extensión cervical del cuello.

Complicación más temida: mediastinitis aguda descendente.

C. Angina de Ludwig

- **Celulitis difusa del piso de la boca** (espacios submandibular, sublingual y submental).
- Generalmente secundaria a infección **odontógena** (2º o 3º molar inferior).
- Curso rápido, sin absceso definido.
- **Elevación de la lengua y edema del cuello con aspecto “en madera”**.

Síntomas:

- Disfagia, disfonía, odinofagia.
 - Babeo, dificultad para deglutir o hablar.
 - Dolor submandibular y proyección hacia cuello.
 - Estridor por compresión de la vía aérea.
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Características diferenciales
Faringoamigdalitis simple	Sin trismus ni desviación de úvula.
Epiglottitis	Estridor, fiebre alta, no hay masa lateral ni trismus.
Absceso dental simple	Dolor localizado, sin compromiso faríngeo.
Tumores del cuello	Curso crónico, afebril.
Angioedema	No febril, sin pus, curso rápido.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

El **diagnóstico inicial es clínico**, basado en signos de edema, trismus y desplazamiento de estructuras faríngeas.

4.2 Exámenes complementarios

Examen	Utilidad
Hemograma / PCR	Evalúa inflamación sistémica y leucocitosis.
TAC cervicofacial con contraste	Gold standard. Identifica extensión, colecciones, nivel del absceso y compromiso de vía aérea o mediastino.

Ecografía cervical Útil para abscesos superficiales o pediátricos.

Cultivo de secreción / aspirado Para identificar microorganismos y sensibilidad.

Hemocultivos En fiebre alta o sospecha de sepsis.

Criterio diagnóstico de absceso: colección líquida encapsulada con realce periférico en TAC contrastado.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Medidas generales

1. **Evaluar y asegurar vía aérea:**
 - En presencia de disnea, estridor o sialorrea → **intubación o traqueostomía urgente.**
 - En Ludwig, la intubación puede ser difícil → **cricotiroidotomía de urgencia** si colapso.
 2. **Hospitalización inmediata** en unidad de ORL o cuidados intensivos.
 3. **Antibioticoterapia EV de amplio espectro.**
-

5.2 Antibióticos recomendados

Cobertura: Streptococcus, Staphylococcus, anaerobios y flora oral.

Opciones según gravedad:

- **Ampicilina/sulbactam 3 g EV c/6h**
- ○ **Ceftriaxona 2 g EV c/24h + Clindamicina 600 mg EV c/8h**
- En alergia a penicilina → **Clindamicina + Ciprofloxacino.**

- En sospecha MRSA → agregar **Vancomicina**.

Duración: 10–14 días, o hasta 48–72 h post drenaje y mejoría clínica.

5.3 Drenaje quirúrgico

- **Absceso periamigdalino:** punción aspirativa o incisión bajo anestesia local.
- **Absceso retrofaríngeo:** drenaje quirúrgico bajo anestesia general.
- **Ludwig:** drenaje amplio cervical bilateral, con incisión submandibular.

Indicaciones de drenaje:

- Evidencia de colección en TAC.
 - Falta de respuesta a antibióticos.
 - Compromiso respiratorio o sepsis.
-

5.4 Medidas adicionales

- **Hidratación EV** y control de electrolitos.
 - **Analgésicos y antipiréticos.**
 - **Corticoides EV** (dexametasona 8 mg c/8h) en edema importante.
 - **Oxigenoterapia y monitoreo respiratorio continuo.**
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Obstrucción de vía aérea	Edema o desplazamiento mecánico.

Mediastinitis descendente	Diseminación por espacios cervicales → mortalidad >40%.
Trombosis séptica de vena yugular interna (síndrome de Lemierre)	Por <i>Fusobacterium necrophorum</i> .
Sepsis y shock séptico	En abscesos retrofaríngeos o Ludwig extensos.
Fístulas o necrosis tisular	Por drenaje tardío.

Pronóstico:

- Excelente con tratamiento precoz y drenaje adecuado.
- Mortalidad <5% si se asegura la vía aérea y control infeccioso.
- Desfavorable en casos con mediastinitis o diagnóstico tardío.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas clínicas

1. **Dolor unilateral + trismus + desviación de úvula = absceso periamigdalino.**
2. **Babeo, rigidez cervical y voz apagada en niños = sospechar absceso retrofaríngeo.**
3. **Edema duro submandibular y elevación de lengua = Angina de Ludwig (emergencia).**
4. **Asegurar vía aérea antes del drenaje.**
5. **El TAC con contraste** es el estudio más útil para delimitar la extensión.
6. **Ampicilina/sulbactam EV** es el antibiótico empírico de elección en Chile.

7. El **síndrome de Lemierre** debe sospecharse ante fiebre persistente y dolor cervical posterior a faringoamigdalitis.
-

✗ Errores comunes

- Retrasar drenaje esperando respuesta antibiótica.
 - Intentar intubación oral en Ludwig sin apoyo quirúrgico (riesgo de paro).
 - No realizar TAC ante duda diagnóstica.
 - No cubrir anaerobios ni MRSA en pacientes graves.
 - Omitir vigilancia de vía aérea en pacientes con trismus o disnea.
 - Considerar “amigdalitis común” cuadros con voz apagada o úvula desviada.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **infecciones profundas del cuello** son potencialmente mortales por **obstrucción de la vía aérea y mediastinitis**.
2. Los tres cuadros más importantes son: **absceso periamigdalino, retrofaríngeo y angina de Ludwig**.
3. **Clínica de alarma**: trismus, voz apagada, desviación de úvula, disfagia, disnea.
4. El **TAC con contraste** es el examen confirmatorio más útil.
5. El manejo se basa en **asegurar vía aérea, antibióticos EV y drenaje quirúrgico**.
6. **Ampicilina/sulbactam** es el tratamiento empírico estándar en Chile.
7. **Ludwig = urgencia vital**: riesgo inminente de asfixia y mediastinitis.